

5A. Cuello: anamnesis dirigida

Separar dolor axial facetario, radiculopatía, mielopatía y hombro periférico antes de plantear una técnica.

Pregunta literal	Si responde SÍ → orienta	Si responde NO → aporta	Qué explorar después
¿El dolor se queda en cuello/occipital/escápula y empeora al mirar arriba o girar?	Patrón facetario cervical posible.	Reduce patrón facetario; no descarta faceta.	ROM, extensión-rotación; MBB si crónico y se plantea RF.
¿El dolor baja por el brazo con hormigueo, quemazón o descarga?	Radiculalgia/radiculopatía cervical.	Reduce radicular; pensar en hombro o dolor referido.	Spurling, distracción, ULTT1 y neurología C5-T1.
¿Empeora al mover el cuello, toser o estornudar?	Refuerza irritación/compresión radicular.	Reduce mecanosensibilidad cervical, no la excluye.	Clúster cervical y distribución por raíz.
¿Al poner la mano del lado doloroso sobre la cabeza disminuye el dolor del brazo?	Bakody positivo: apoya radiculopatía cervical.	No excluye radiculopatía; si duele hombro, valorar manguito.	Bakody, distracción y exploración de hombro si procede.
¿Le duele sobre todo al elevar o mover el hombro y el cuello influye poco?	Generador periférico de hombro.	Reduce hombro aislado; pueden coexistir ambos.	Arco, manguito, AC y ecografía de hombro.
¿Ha perdido fuerza, se le caen objetos o nota adormecimiento persistente?	Radiculopatía con déficit o posible médula.	Reduce déficit objetivo; no dolor radicular.	Fuerza, sensibilidad, reflejos y RM si concordante.
¿Tiene torpeza de manos, marcha inestable o urgencia/incontinencia nueva?	Mielopatía cervical hasta demostrar lo contrario.	Reduce alarma, pero no excluye mielopatía inicial.	Hoffmann, clonus, hiperreflexia, marcha y RM prioritaria.

SÍNTESIS DE ANAMNESIS

Antes de infiltrar una cervicobraquialgia hay que documentar fuerza, sensibilidad y reflejos. Bakody es una pregunta/manobra de alivio; cualquier pista de médula cambia el algoritmo.

5B. Cuello: exploración esencial guiada

Un test solo se considera positivo si reproduce el dolor o el síntoma habitual en la localización esperada. Comparar lados cuando sea apropiado y no diagnosticar por una maniobra aislada.

Test	Cómo se hace	Positivo → qué implica	Negativo → qué implica
Spurling	Extender, inclinar y rotar hacia lado sintomático; aplicar compresión axial suave solo si es seguro.	Reproduce dolor/parestesias radicales habituales en brazo: aumenta probabilidad de radiculopatía.	No excluye radiculopatía por sensibilidad limitada.
Distracción cervical	Supino o sentado, sujetar occipucio/mentón y aplicar tracción axial suave.	Alivia claramente el dolor braquial habitual: apoya compresión radicular.	No excluye radiculopatía; el síntoma puede no responder a tracción.
ULTT1 mediano	Depresión escapular, abducción, supinación, extensión muñeca/dedos, rotación externa y extensión de codo; inclinar cuello para diferenciar.	Reproduce síntomas neuroanatómicos que cambian con cuello: mecanosensibilidad neural; positivo aislado es poco específico.	Un ULTT1 negativo reduce la probabilidad de radiculopatía cervical.
Rotación <60°	Girar activamente hacia el lado sintomático y estimar/medir el rango sin compensación.	Menos de 60° forma parte del clúster de radiculopatía; no diagnostica sola.	Más de 60° resta un elemento al clúster, pero no excluye.
Bakody	El paciente coloca la mano del lado sintomático sobre la cabeza, abduciendo el hombro.	Disminuyen dolor irradiado o parestesias: Shoulder Abduction Relief Sign positivo, apoya radiculopatía cervical.	No excluye radiculopatía. Si provoca dolor local de hombro, explorar manguito/BSASD.
Arm Squeeze	Comprimir moderadamente el tercio medio del brazo sobre bíceps/tríceps y comparar con AC/subacromial.	Dolor claramente mayor en brazo medio: apoya origen cervical frente a hombro.	No descarta origen cervical ni confirma hombro; integrar con neurología.
Neurología C5-T1	Fuerza, sensibilidad y reflejos bicipital, estilogartrial y tricipital, comparando lados.	Déficit miotómico, dermatómico o reflejo reducido concordante: radiculopatía y posible lesión axonal.	Normal no excluye radiculalgia sin déficit objetivo.
Hoffmann	Sujetar dedo medio relajado y chasquear distalmente la falange/uña hacia flexión.	Flexión/adducción involuntaria de pulgar/índice: signo piramidal; con clínica, sospechar mielopatía.	No excluye mielopatía; puede ser unilateral, bilateral o incluso incidental.
Clonus + marcha	Dorsiflexión brusca sostenida del tobillo; después marcha normal, talón-punta y tándem.	Clonus sostenido o marcha espástica/inestable: posible afectación medular; RM/derivación prioritaria.	No excluye mielopatía inicial; pesan torpeza manual, hiperreflexia y progresión.

SÍNTESIS CLÍNICA

Para radiculopatía, usar clúster: historia concordante + Spurling/distracción/ULTT/rotación y neurología. Bakody es una prueba de alivio, no de provocación. Cualquier signo de médula cambia el algoritmo y desaconseja infiltrar sin aclarar el diagnóstico.

5C. Cervical: bloqueos y tratamiento seguro

La ecografía ayuda a visualizar raíces, vasos y ramos mediales en manos expertas, pero no sustituye la RM ni todos los controles de seguridad.

Escenario	Opción	Límite / seguridad
Dolor facetario crónico	MBB cervical ecoguiado en operadores expertos o fluoroscópico; respuesta concordante → RF con técnica e imagen apropiadas.	Evitar sedación si invalida respuesta; no hacer RF por RM degenerativa aislada.
Radiculopatía sin déficit progresivo	Educación, actividad graduada, fisioterapia; epidural cervical en casos seleccionados tras RM y consentimiento.	Beneficio sobre todo corto; complicaciones raras pero graves.
Bloqueo selectivo de raíz	Puede tener valor diagnóstico/terapéutico especializado.	La ecografía identifica vasos, pero no garantiza ausencia de flujo intravascular/foraminal; seguir protocolo estricto.
Déficit progresivo o mielopatía	Derivación a cirugía de columna/neurocirugía.	No retrasar con ciclos repetidos de corticoide o infiltraciones.

FARMACOLOGÍA	AINE corto si no hay contraindicaciones. No existe una pauta universal de prednisona 30 mg descendente para toda cervicobraquialgia; la evidencia de corticoide oral es limitada y deben ponderarse diabetes, infección, HTA, osteoporosis y diagnóstico. Neuromoduladores solo si fenotipo neuropático claro y balance beneficio-riesgo.
FISIOTERAPIA	6-8 sesiones iniciales repartidas en 6-10 semanas si precisa supervisión: educación, exposición gradual, movilidad, control cervicoescapular, fuerza y neurodinamia seleccionada. Tracción puede ser coadyuvante en algunos pacientes; evitar dependencia de terapias pasivas.
MENSAJE AL PACIENTE	Buscamos reducir la irritación del nervio y vigilar que conserve fuerza. Una infiltración puede facilitar la recuperación, pero si aparece debilidad progresiva, torpeza de manos o alteración de la marcha cambia la prioridad y hay que valorar cirugía.

5D. Cuello: pauta práctica

Dosis orientativas para adulto no frágil. Individualizar por edad, peso, embarazo, alergias, función renal/hepática, riesgo GI/CV, anticoagulación y medicación concomitante.

CÓMO PRESCRIBIR

Elegir una sola estrategia analgésica principal, fijar fecha de fin y revisar una tarea funcional. Paracetamol: máximo conservador 3 g/día. No combinar AINE. En paciente de riesgo GI que precise AINE, valorar omeprazol 20 mg/día durante el curso.

Cuadro	Fármaco • dosis	Duración / revisión
Axial mecánico	Ibuprofeno 400 mg/8 h O naproxeno 250-500 mg/12 h si es seguro.	5-7 días; mantener movilidad tolerada.
Rescate	Paracetamol 500-1.000 mg/8 h si precisa (máx. 3 g/día).	3-5 días.
Neuropático seleccionado	Duloxetina 30 mg/día 1-2 semanas y después 60 mg/día; alternativa amitriptilina 10 mg/noche, subir semanalmente hasta 25-50 mg.	Ensayo 6-8 semanas; revisar TA, tolerancia, función y retirada gradual.
Cervicobraquialgia	No adoptar prednisona descendente como pauta universal; decidir caso a caso tras descartar mielopatía/infección.	Revisión precoz si déficit, dolor progresivo o sueño muy alterado.

Bloqueo / técnica	Fármaco propuesto	Volumen y guardarraíl
MBB cervical	Lidocaína 1-2% o bupivacaína 0,25-0,5%; sin corticoide.	0,2-0,3 mL por ramo; volumen bajo para especificidad.
Epidural cervical interlaminar	Dexametasona no particulada 10 mg + suero salino, con o sin anestésico local según protocolo.	Total 3-5 mL; RM previa y técnica radiológica estandarizada.
Transforaminal / raíz	Dexametasona no particulada 10 mg + salino 0,9%.	Total 1-2 mL; nunca particulado; contraste y vigilancia vascular.
RF cervical	Lidocaína 1% para piel; lidocaína 2% 0,5-1 mL por diana antes de lesión según protocolo.	Sin corticoide rutinario; estimulación y control de imagen.

REHABILITACIÓN

Movilidad, resistencia cervical y cintura escapular, neurodinamia seleccionada y exposición gradual 6-10 semanas; 4-8 sesiones supervisadas.

EVITAR

Epidural sin RM o con mielopatía, corticoide particulado cervical transforaminal, sedación profunda que invalide el bloqueo diagnóstico o técnicas para retrasar cirugía ante déficit progresivo.